

Wrażliwość *na odrzucenie*

Krótką, nieostrą wiadomość → katastrofa w środku. Krytyka → atak na całą tożsamość. To nie BPD — to RSD.

CZAS: 15 min czytania Stosuj w momencie „crashu”

ŹRÓDŁO: Dodson (2017, koncepcja kliniczna); Bedrossian (2021); Gao i wsp. (2023)

JAK UŻYWAĆ

Gdy poczujesz nagły emocjonalny „crash” po krytyce, wiadomości lub porażce: **nazwij to RSD**. Odłóż reakcję o **30 minut** — nie pisz, nie dzwoń, nie zrywaj. Oddech 4-6-8 trzy razy. Powiedz sobie: „To jest RSD, nie rzeczywistość — wróci do mnie za 1-2 godziny”. Tylko tyle. Resztę zostaw na potem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

RSD (ang. *rejection sensitive dysphoria*) — koncepcja kliniczna Williama Dodsona (2017): **intensywna, trudna do zniesienia** reakcja emocjonalna na *realne lub postrzegane* odrzucenie, krytykę lub porażkę. Występuje u ok. **70%** dorosłych z ADHD. Mechanizm dwuczynnikowy: (1) biologiczna dysregulacja emocji (Barkley 2015) plus (2) *uczulenie* przez lata krytyki w dzieciństwie („leniwy”, „głupi”, „nieuważny”). Gao i wsp. (2023, meta-analiza): osoby z ADHD wykazują podwyższoną reaktywność na negatywną informację zwrotną ($d = 0,58$). RSD **nie jest** w DSM-5, ale klinicznie kluczowe — często mylone z BPD.

01 ? Cztery cechy odróżniające RSD

1 · NAGŁE I INTENSYWNE

W **kilka sekund** od bodźca. Nie narastające. Pełna intensywność od pierwszej chwili. „Spadasz” w dół wagi 0–10 niemal natychmiast.

2 · WYRAŹNY WYZWAŁACZ

Odrzucenie, krytyka, porażka, *postrzegana* izolacja. „Krótka odpowiedź” partnera. Nieoddzwoniony telefon. Komentarz szefa. Mała rzecz, duża reakcja.

3 · KRÓTKOTRWAŁE

1–2 godziny do dnia. **Nie tygodniami** jak w depresji. To wskazówka różnicowa: jutro lub pojutrze emocja opada sama. *Surfing*, nie walka.

4 · DWA TYPY REAKCJI

Do wewnątrz: wstyd, depresja, wycofanie („nikt mnie nie lubi”). **Na zewnątrz:** gniew, atak słowny, „spalenie mostów”. Wybór zależy od historii.

02 ☉ RSD ≠ BPD — różnicowanie kliniczne

RSD W ADHD

- Reakcja **na bodziec** — coś się stało
- Trwa godziny, najwyżej dzień
- Po opadnięciu: „widzę, że przesadziłem/-am”
- Tożsamość względnie stabilna
- Lęk przed porzuceniem **nieobecny**
- Brak samouszkodzeń jako wzorzec

ZABURZENIE OSOBOWOŚCI Z POGRANICZĄ

- Reakcja często **na samą myśl** o opuszczeniu
- Trwa dni — tygodnie
- Po fali: *nadal silna interpretacja*
- Niestabilna tożsamość (idealizacja↔dewaluacja)
- Lęk przed porzuceniem **centralny**
- Samouszkodzenia jako wzorzec regulacji

Filipsen i wsp. (2008): **14–25%** osób z BPD ma także ADHD — diagnozy współistnieją. Ale tylko ADHD bez BPD to **nie BPD**, mimo wyglądu. Różnicowanie u terapeuty.

03 Pięć kroków w momencie crashu

1 • ROZPOZNAJ

„Mam atak RSD”. Sama nazwa obniża aktywność ciała migdałowatego (Lieberman i wsp., 2007). Pierwszy krok to **zauważenie wzorca**, nie ucieczka.

2 • ODDECH 4-6-8

Wdech 4 sekundy. Wstrzymanie 6. Wydech 8. **Trzy razy**. Aktywuje przywspółczulny układ nerwowy. Sekundy, ale działają.

3 • ODŁÓŻ REAKCJĘ 30 MIN

Nic nie pisz, nic nie mów, nic nie wysyłaj. Reguła Mela Robbinsa: nie podejmuj decyzji na szczycie fali. Telefon w drugim pokoju.

4 • SPRAWDŹ FAKTY

„Co dokładnie powiedział/-a?” vs „Co usłyszałem/-am?”. Po 30 min zapisz *literalnie* słowa, nie interpretację. Często okazuje się, że rzeczywistość była mniej dotkliwa.

5 • ZACZEKAJ NA OPADNIĘCIE FALI — 1-2 GODZINY

RSD **kończy się sama**. To kluczowe odróżnienie od depresji. Pójdź na spacer, zrób coś prostego, posłuchaj muzyki. Decyzje, rozmowy, odpisywanie — *po* opadnięciu. Nie wcześniej.

04 Dziennik RSD — 3 ostatnie epizody

Wypełnij dla 3 ostatnich epizodów. Po 5-10 wpisach zaczynasz *rozpoznawać wzorzec* — wyzwalacze, typowe interpretacje, czas trwania. To podstawa pracy terapeutycznej z RSD.

1

WYZWALACZ

MOJA INTERPRETACJA (VS FAKTY)

2

WYZWALACZ

MOJA INTERPRETACJA (VS FAKTY)

3

WYZWALACZ

MOJA INTERPRETACJA (VS FAKTY)

Klucz: RSD nie jest „nadwrażliwością” ani winą. To *biologiczne uczulenie* mózgu ADHD na sygnały odrzucenia. Dodson (2019) szacuje: 99% dorosłych z ADHD zna to z autopsji, 70% opisuje jako *najtrudniejszy* aspekt ADHD. Lekarstwo: **psychoedukacja + opóźnienie reakcji + farmakoterapia** u opornych przypadków (agoniści alfa-2 — klonidyna, guanfacyna; konsultacja z psychiatrą). RSD nie znika całkowicie, ale przestaje rządzić życiem.